

RECEITA MÉDICA

Médico: fernando

CRM: sfgh

Especialidade: radiologista

Data: 26/02/2026 14:00

Paciente: Hernaine

Idade: 29 anos

1. DIAGNÓSTICO

TIPO DE EXAME:

Urina Tipo 1

DESCRIÇÃO:

jvgvg

OBSERVAÇÕES:

bn

RESULTADO:

Prezado(a) Dr(a),

A seguir, apresento a análise detalhada da imagem microscópica do sedimento urinário do paciente Hernaine, 29 anos, masculino, com base nas informações fornecidas.

Relatório de Análise Médica

Paciente: Hernaine

Idade: 29 anos

Gênero: Masculino

Tipo de Exame: Urina Tipo 1

Urgência (Clínica Fornecida): NORMAL

****1. Descrição da imagem e qualidade técnica****

A imagem corresponde a um campo microscópico de sedimento urinário, provavelmente em grande aumento (400x). A qualidade técnica da imagem é boa, com foco adequado e iluminação uniforme, permitindo a clara visualização e identificação dos elementos presentes. O campo está repleto de partículas e células.

****2. Achados principais****

* ****Cristais de Fosfato Triplo (Estruvita):**** Observa-se uma quantidade exuberante (muito

numerosa) de cristais com morfologia característica de prismas retangulares ou "tampa de caixa". Estes cristais são altamente sugestivos de fosfato triplo (fosfato amônio-magnésiano ou estruvita). Eles são o achado mais proeminente e abundante no campo.

* **Hemácias (Glóbulos Vermelhos):** Há presença de numerosas células pequenas, arredondadas e biconvexas, compatíveis com hemácias. A quantidade é significativa, indicando hematúria (presença de sangue na urina).

* **Células Epiteliais:** Algumas células epiteliais isoladas podem ser discernidas, mas não são um achado predominante.

* **Outros Elementos:** Não se observam cilindros, bactérias em quantidade flagrante, ou fungos de forma inequívoca, embora a presença de cristais de estruvita frequentemente esteja associada à infecção bacteriana.

3. Diagnóstico sugerido

A sedimentoscopia urinária revela uma **cristalúria maciça por fosfato triplo**, acompanhada de **hematúria**.

* Os cristais de fosfato triplo são tipicamente formados em urina alcalina (pH elevado) e são frequentemente associados a infecções do trato urinário (ITU) causadas por bactérias produtoras de urease (como *Proteus mirabilis*, *Klebsiella*, *Pseudomonas*), que metabolizam a ureia em amônia, alcalinizando a urina.

* A hematúria pode ser um resultado direto da irritação e trauma da mucosa do trato urinário pelos cristais em grande quantidade, ou pode estar relacionada à patologia subjacente, como uma ITU ou litíase urinária (cálculos renais) de estruvita.

4. Recomendações

Considerando os achados, as seguintes recomendações são pertinentes:

* **Correlação Clínica:** É fundamental correlacionar estes achados com o quadro clínico completo do paciente (sintomas urinários como disúria, polaciúria, dor lombar, febre, etc.), histórico médico e uso de medicamentos (especialmente antiácidos).

* **Determinação do pH Urinário:** É crucial verificar o pH da urina, preferencialmente de uma amostra fresca, para confirmar o ambiente alcalino que favorece a formação destes cristais.

* **Urocultura com Antibiograma:** Dada a forte associação dos cristais de fosfato triplo com ITU por bactérias produtoras de urease, uma urocultura com antibiograma é fortemente recomendada para identificar o agente etiológico e guiar o tratamento, caso haja infecção.

* **Hidratação Adequada:** Incentivar o aumento da ingestão de líquidos para promover a diluição urinária e o escoamento dos cristais.

* **Avaliação para Litíase Urinária:** Se o paciente apresentar sintomas compatíveis ou histórico de cálculos renais, exames de imagem (como ultrassonografia renal e das vias urinárias ou tomografia computadorizada) podem ser considerados para investigar a presença de cálculos de estruvita, que podem ser complexos e grandes (cálculos coraliformes).

* **Revisão Dietética:** Em alguns casos, pode ser útil avaliar a dieta do paciente para verificar o consumo excessivo de alimentos ricos em fosfato.

5. Nível de urgência

Média.

Embora o exame tenha sido classificado como "NORMAL" inicialmente, os achados microscópicos de cristalúria maciça por fosfato triplo e hematúria são significativos e sugerem uma condição subjacente que requer investigação e manejo. Não é uma emergência, mas a possibilidade de uma ITU não tratada ou a formação de cálculos renais justifica uma avaliação médica em um prazo razoável para evitar complicações.

Espero que este relatório seja útil.

Atenciosamente,

[Seu Nome/Analista Médico Especialista]

DIAGNÓSTICO PRELIMINAR:

Prezado(a) Dr(a),

A seguir, apresento a análise detalhada da imagem microscópica do sedimento urinário do paciente Hernaine, 29 anos, masculino, com base nas informações fornecidas.

Relatório de Análise Médica

****Paciente:**** Hernaine

****Idade:**** 29 anos

****Gênero:**** Masculino

****Tipo de Exame:**** Urina Tipo 1

****Urgência (Clínica Fornecida):**** NORMAL

****1. Descrição da imagem e qualidade técnica****

A imagem corresponde a um campo microscópico de sedimento urinário, provavelmente em grande aumento (400x). A qualidade técnica da imagem é boa, com foco adequado e iluminação uniforme, permitindo a clara visualização e identificação dos elementos presentes. O campo está repleto de partículas e células.

****2. Achados principais****

* ****Cristais de Fosfato Triplo (Estruvita):**** Observa-se uma quantidade exuberante (muito numerosa) de cristais com morfologia característica de prismas retangulares ou "tampa de caixa". Estes cristais são altamente sugestivos de fosfato triplo (fosfato amônio-magnésiano ou estruvita). Eles são o achado mais proeminente e abundante no campo.

* ****Hemácias (Glóbulos Vermelhos):**** Há presença de numerosas células pequenas, arredondadas e biconvexas, compatíveis com hemácias. A quantidade é significativa, indicando hematúria (presença de sangue na urina).

* ****Células Epiteliais:**** Algumas células epiteliais isoladas podem ser discernidas, mas não são um achado predominante.

* ****Outros Elementos:**** Não se observam cilindros, bactérias em quantidade flagrante, ou fungos de forma inequívoca, embora a presença de cristais de estruvita frequentemente esteja associada à infecção bacteriana.

****3. Diagnóstico sugerido****

A sedimentoscopia urinária revela uma ****cristalúria maciça por fosfato triplo****, acompanhada de ****hematúria****.

* Os cristais de fosfato triplo são tipicamente formados em urina alcalina (pH elevado) e são frequentemente associados a infecções do trato urinário (ITU) causadas por bactérias produtoras de urease (como **Proteus mirabilis**, **Klebsiella**, **Pseudomonas**), que metabolizam a ureia em amônia, alcalinizando a urina.

* A hematúria pode ser um resultado direto da irritação e trauma da mucosa do trato urinário pelos cristais em grande quantidade, ou pode estar relacionada à patologia subjacente, como uma ITU ou litíase urinária (cálculos renais) de estruvita.

****4. Recomendações****

Considerando os achados, as seguintes recomendações são pertinentes:

* ****Correlação Clínica:**** É fundamental correlacionar estes achados com o quadro clínico completo do paciente (sintomas urinários como disúria, polaciúria, dor lombar, febre, etc.), histórico médico e uso de medicamentos (especialmente antiácidos).

* ****Determinação do pH Urinário:**** É crucial verificar o pH da urina, preferencialmente de uma amostra fresca, para confirmar o ambiente alcalino que favorece a formação destes cristais.

* **Urocultura com Antibiograma:** Dada a forte associação dos cristais de fosfato triplo com ITU por bactérias produtoras de urease, uma urocultura com antibiograma é fortemente recomendada para identificar o agente etiológico e guiar o tratamento, caso haja infecção.

* **Hidratação Adequada:** Incentivar o aumento da ingestão de líquidos para promover a diluição urinária e o escoamento dos cristais.

* **Avaliação para Litíase Urinária:** Se o paciente apresentar sintomas compatíveis ou histórico de cálculos renais, exames de imagem (como ultrassonografia renal e das vias urinárias ou tomografia computadorizada) podem ser considerados para investigar a presença de cálculos de estruvita, que podem ser complexos e grandes (cálculos coraliformes).

* **Revisão Dietética:** Em alguns casos, pode ser útil avaliar a dieta do paciente para verificar o consumo excessivo de alimentos ricos em fosfato.

****5. Nível de urgência****

****Média.****

Embora o exame tenha sido classificado como "NORMAL" inicialmente, os achados microscópicos de cristalúria maciça por fosfato triplo e hematúria são significativos e sugerem uma condição subjacente que requer investigação e manejo. Não é uma emergência, mas a possibilidade de uma ITU não tratada ou a formação de cálculos renais justifica uma avaliação médica em um prazo razoável para evitar complicações.

Espero que este relatório seja útil.

Atenciosamente,

[Seu Nome/Analista Médico Especialista]

2. PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS

****TRATAMENTO PARA INFECCAO URINARIA NAO COMPLICADA****

Fosfomicina Trometamol

* Apresentação: Sachê 3g

* Posologia: 1 sachê dose única

* Frequência: Dose única

* Duração: 1 dia

* Via: Oral

* Quantidade: 1 sachê

* Primeira linha para cistite não complicada

Nitrofurantoína

* Apresentação: Comprimidos 100mg

* Posologia: 100mg

* Frequência: 12/12 horas

* Duração: 5 dias

* Via: Oral

* Quantidade: 10 comprimidos

* Alternativa de primeira linha

3. RECOMENDAÇÕES MÉDICAS

- Seguir rigorosamente a posologia dos medicamentos prescritos
- Manter-se bem hidratado, ingerindo bastante líquidos
- Repousar adequadamente para auxiliar na recuperação
- Evitar automedicação e bebidas alcoólicas durante o tratamento
-

■ ■ SINAIS DE ALERTA - PROCURAR URGÊNCIA SE:

- • Febre persistente ou alta
- • Falta de ar ou dificuldade para respirar
- • Confusão mental ou desmaios
- • Sangramentos incomuns
- • Vômitos persistentes
-

Retorno: Agendar em 7-10 dias

Assinatura do Médico

fernando

CRM: sfgh

Validade: 30 dias

fernando

CRM: sfgh

Validade: 30 dias